2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

A interlocução entre os serviços de saúde mental com a Estratégia de Saúde da Família: um relato de experiência

Quésia Ferreira da Silva - CNaR 3.2 (SMS/RJ) e IMAS Philippe Pinel (SMS/RJ);
Diogo Simonaci - IMAS Philippe Pinel (SMS/RJ);
Luiz Henrique Santana da Cunha - IMAS Philippe Pinel (SMS/RJ);
Rosimara de Souza Rocha - IMAS Philippe Pinel (SMS/RJ).

Legenda: Visita de rua em uma ocupação urbana (SILVA, 2022).

PRINCIPAIS ACHADOS DO TRABALHO

A articulação entre a Estratégia Saúde da Família e a Rede de Atenção Psicossocial fortalece a continuidade e a integralidade do cuidado em saúde mental, com destaque para o papel estratégico da APS na coordenação do cuidado no território. Apesar dos avanços, persistem desafios na comunicação e nos fluxos entre os serviços.

Introdução

O processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) desenvolve-se de modo indissociável da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF) como ordenadora da Atenção Primária à Saúde (APS). À luz do princípio da regionalização, que organiza a rede de serviços em territórios sanitários integrados, a articulação entre CAPS, enfermaria de saúde mental em hospital geral e APS constitui elemento estratégico para a integralidade e continuidade do cuidado (Silva e Ferigato, 2020; Ribeiro e Inglez-Dias, 2011).

Objetivos

Descrever a interlocução entre os serviços de saúde mental e ESF, destacando fluxos assistenciais e mecanismos de coordenação do cuidado no âmbito local.

Métodos

O presente estudo consiste em um relato de experiência que narra a vivência de enfermeiros que atuam em uma emergência de um hospital psiquiátrico, integrante da RAPS regional do Município do Rio de Janeiro.

A porta de entrada ocorre por demanda espontânea, SAMU, CBMERJ ou vaga zero (ESF e rede hospitalar). Quando o usuário dá entrada na unidade, se torna responsabilidade da instituição a contrarreferência deste para a continuidade do cuidado em unidades de atenção psicossocial assim como no território com o apoio da ESF. Enfatizando a referência e contrarreferência como elemento central para a articulação de rede e a corresponsabilização entre os serviços e garantia da integralidade do cuidado (Campos, 2003).

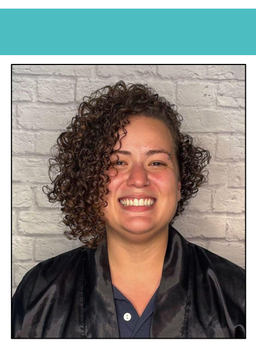
De acordo com a Política Nacional de Atenção Primária (PNAB, 2017), a APS é responsável pela porta de entrada dos usuários no SUS e também pelo cuidado integral à população adscrita, organização do cuidado no território, coordenação do cuidado em rede e do trabalho interdisciplinar e comunitário. No que se refere à RAPS, essa se configura como uma das principais estratégias de organização do cuidado em saúde mental no SUS.

A saída do usuário da emergência psiquiátrica pode ocorrer por diferentes modalidades de encaminhamento. Entre as possibilidades, destacam-se: alta médica; encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial tipo II (CAPS II); transferência para acolhimento noturno em Centro de Atenção Psicossocial tipo III (CAPS III), tanto para público adulto quanto infantojuvenil; transinstitucionalização para outro nosocômio (seja para leito clínico em saúde mental ou leito psiquiátrico no município de origem do usuário), ou ainda internação na própria unidade hospitalar.

Além disso, há situações envolvendo pacientes em conflito com a lei, nas quais se estabelece interlocução com o CAPS para articulação do cuidado no contexto da audiência de custódia. Nesses casos, é elaborada documentação médica que ateste a presença de transtorno psíquico, a qual pode subsidiar decisões judiciais, como a conversão da prisão em internação para tratamento ou o encaminhamento direto para acompanhamento em serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Conclusão

Evidenciou-se que a regionalização, associada à APS como ordenadora do cuidado, favorece a corresponsabilização entre pontos da rede, reduz descontinuidades e qualifica a atenção psicossocial em perspectiva territorial.

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro
Quésia Ferreira da Silva
Enfª assistencial Consultório na Rua AP 3.2
Enfª supervisora IMAS Philippe Pinel

E-mail: quesia50@gmail.com
Contatos: (21) 98649-0276